Riesgo percibido del efecto del consumo de alcohol sobre el feto en mujeres en edad fértil

Programa de Doctorado en Investigación en Psicología

Facultat de Psicologia i Logopèdia

Defensa de **Tesis Doctoral**

Presentada por **Maria Botella López**

Dirigida por **María Teresa Cortés Tomás**

Valencia, septiembre de 2026

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

2 MÉTODO

3 RESULTADOS

4 DISCUSIÓN

Si la recomendación es clara...

Entonces, ¿por qué persiste el consumo de alcohol en el embarazo?



INTRODUCCIÓN

1. El consumo no empieza con el embarazo

CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES EN POBLACIÓN GENERAL (15-64 AÑOS)

91,7%	71,2%	56%
Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días

Mayor consumo: **25-34 años** → Coincide con **edad reproductiva media**

INE (2023) y UNECE (2023)

Binge drinking

11,7%

último mes

Mayor consumo: **20-29 años**

EDADES 2024 (OEDA, 2025)

CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES MENORES DE EDAD (14-18 AÑOS)

75,3%	72,5%	52,2%
Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días

Inicio medio: **13,9 años · Consumo creciente con la edad**

Binge drinking

23,3%

último mes

ESTUDES 2025 (OEDA, 2025)

Consumo normalizado

↓

Patrones previos en edad reproductiva

↓

Mayor riesgo de exposición prenatal

2. Durante el embarazo el consumo disminuye, pero persiste

ANTES DEL EMBARAZO

22,6–98%

EUROPA — 30,5%–98%

- Rusia: 94%–98%
- Escocia / Suecia: 84%–92%
- Irlanda / Reino Unido: 77%–90%
- Bélgica: 82%
- Países Bajos: 30,5%–68,9%
- Francia / Dinamarca: ~52%
- Italia: ~40%

FUERA DE EUROPA — 22,6%–70%

- EE. UU. / Canadá: 53,6%–70%
- Israel: 67,2%
- Australia: 38%–61%
- Nigeria: 22,6%

DURANTE EL EMBARAZO

4–75%

ESTIMACIÓN — ~10% mundial

- Europa: 25,2%
- Máximos: Irlanda 60,4%, Bielorrusia 46,6%, Dinamarca 45,8%, Reino Unido 41,3%, Rusia 36,5%

EUROPA — 5%–64%

- Escocia / Rusia: 18%–64% | 21%–47%
- Bélgica: 41% pre-reconocimiento> 12% post-confirmación
- Irlanda / Dinamarca / Países Bajos: 5%–32% | 20%–31% | 19%–22%
- Estudios multinacionales: 15,8% | Eslovaquia: 24,6%
- España / Italia: ~12% | Francia / Suecia: 5%–6%

FUERA DE EUROPA — 4%–75%

- EE. UU.: 6,3%–10,2%
- Filipinas: 75%
- Etiopía: 30,3% | Tanzania: 4%–42,2%
- Brasil: 23% | Australia: 18%–27% | Israel: 12%

ESPAÑA

10–64,7%

ESTIMACIÓN	10%–15%
AUTOINFORME	25%–27,2%
BIOMARCADORES	45%–64,7%

Biomarcador vs autoinforme

20,2% en cabello vs. **20,7%** autoinforme

Fuentes: Addila et al., 2021; Backhausen et al., 2014; Bakhireva et al., 2017; Balachova et al., 2019; Blasco-Alonso et al., 2015; Corrales-Gutiérrez et al., 2019, 2023; Dumas et al., 2017; Eisenberg et al., 2025; García-Algar et al., 2008; Godfrey et al., 2025; Gómez-Roig et al., 2018; Hen-Herbst et al., 2021; Howlett et al., 2017; Huang et al., 2023; Lanting et al., 2015; Lenie et al., 2025; Mårdby et al., 2017; McCormack et al., 2017; Morini et al., 2013; Muggli et al., 2016; Murphy et al., 2014; O'Keeffe et al., 2015; Onwuka et al., 2016; Peltier et al., 2025; Popova et al., 2017; Sbrana et al., 2016; Skagerström et al., 2013; Symon et al., 2016; Tan et al., 2015; van der Windt et al., 2024; West et al., 2024; Zaçe et al., 2024; Zahumensky et al., 2024.

3. ¿Qué factores se han asociado al consumo gestacional?

Sociodemográficos

Rentas altas

Edad ≥30–35 años, educación superior y empleo → mayor consumo y *binge drinking*
(McCormack et al., 2017; Saxov, 2023; Tan et al., 2015)

Rentas bajas

Edad ≤30 años y menor nivel educativo → mayor consumo
(Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Onwuka et al., 2016)

Estado civil

No estar casada → mayor consumo
(Bete et al., 2023; Peltier et al., 2025)

Etnia

Caucásica en rentas altas (O'Keeffe et al., 2015) vs. **grupos desfavorecidos** en rentas bajas (Aryal et al., 2016) → mayor consumo

Obstétricos

Planificación

Embarazo no planificado → mayor consumo
(McCormack et al., 2017; Petersen-Williams et al., 2018)

Paridad: doble patrón

- **Primíparas** → mayor riesgo (O'Keeffe et al., 2015; Saxov et al., 2023)
- **Multíparas** → mayor riesgo (Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Senecky et al., 2025).

Aborto previo

Mayor consumo
(Bete et al., 2023)

Conductuales

Consumo previo

Predictor más robusto. Consumo previo de alcohol → mayor consumo gestacional
(Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Senecky et al., 2025; Skagerström et al., 2011; 2013; Tsang et al., 2022).

Tabaquismo

Fumar antes/durante embarazo → mayor ingesta gestacional
(Dumas et al., 2017; McCormack et al., 2017; Saxov et al., 2023; Senecky et al., 2025).

Sociales

Conducta de pareja

Consumo de **alcohol, tabaco** o **drogas** → facilitador del consumo
(Aryal et al., 2016; Petersen-Williams et al., 2018; Saxov et al., 2023)

Apoyo social

Falta de red de apoyo → mayor consumo
(Skagerström et al., 2013)

Trauma y salud mental

Antecedentes de **violencia, abuso, judiciales o psiquiátricos** → mayor consumo
(Bete et al., 2023; Peltier et al., 2025; Skagerström et al., 2011)

Psicosociales

Percepción del riesgo

Baja percepción → mayor consumo
(Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Tsang et al., 2022)

Conocimiento de consecuencias

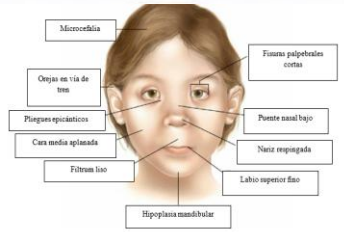
Desconocimiento → mayor consumo
(Aryal et al., 2016; Onwuka et al., 2016)

Poco estudiados, pero claves en la toma de decisiones

4. ¿Por qué importa? Consecuencias de la exposición prenatal

MALFORMACIONES FÍSICAS

- Rasgos craneofaciales típicos
- Anomalías cardíacas, renales y digestivas
- Alteraciones músculo-esqueléticas
- Alteraciones visuales y auditivas
- Alteraciones sistema reproductor
- Déficit de crecimiento.



AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

ETAPA TEMPRANA (0-2 AÑOS)

- Alteración autorregulatoria: irritabilidad, baja autoconsolación, retraimiento emocional y regulación anómala del estrés/dolor.
- Retraso psicomotor fino/grueso y dificultades de succión/alimentación.

ETAPA INFANTOJUVENIL (2-18 AÑOS)

- Coeficiente intelectual límite/bajo y déficit en funciones ejecutivas (FFEE): flexibilidad, inhibición, abstracción, memoria de trabajo y perseveración. Alteraciones del lenguaje.
- Dificultades en habilidades sociales y de la vida diaria. Problemas de conducta y de regulación emocional.
- Comorbilidad.

ETAPA ADULTA

- Deterioro intelectual global. Afectación de las FFEE.
- Expresión emocional y conductas muy variadas y/o desadaptativas para la edad.

DÉFICITS SECUNDARIOS
Abandono académico, problemas laborales, conductas de riesgo, conflictos con el sistema legal/judicial, etc.

Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal



Síndrome Alcohólico Fetal · Síndrome Alcohólico Fetal Parcial · Trastorno del Neurodesarrollo Relacionado con el Alcohol · Defectos de Nacimiento Relacionados con el Alcohol

IOM-Hoyme et al. (2016)

Fuentes: Akison et al., 2019; Andreu-Fernández et al., 2021; Astals Vizcaíno et al., 2021; Bookstein et al., 2002; Doyle y Mattson, 2015; Hoyme et al., 2016; Krasemann y Klingebiel, 2007; Lees et al., 2020; Ogunjimi et al., 2025; Olson y Sparrow, 2021; Streissguth et al., 1996; Subramoney et al., 2018; Wozniak et al., 2019.

5. Prevalencia de TEAF: un problema probablemente infraestimado

PREVALENCIA MUNDIAL

7,7/1.000

Prevalencia media mundial estimada de TEAF en población infantojuvenil

1,5/1.000

Prevalencia media mundial estimada de SAF en población general

(Lange et al., 2017; Popova et al., 2017; WHO, 2018)

La prevalencia estimada más alta de SAF: región europea: 3,7/1000

(Popova et al., 2017)

PREVALENCIA ESPAÑA

2–3/1.000

Estimación de SAF en España

(Popova et al., 2017)

Posible infraestimación:

- Diferentes criterios diagnósticos
- Elevada comorbilidad
- Falta de formación y habilidad del personal sanitario
- Uso de cuestionarios vs biomarcadores

CONTEXTOS VULNERABLES

Subpoblaciones de riesgo

Menores institucionalizados o en acogida, poblaciones indígenas, exclusión social o con déficit intelectual:

10-40% superior a las cifras estimadas para población general

(Popova et al., 2019)

Adopción internacional en España:

50%

TEAF en una muestra de menores adoptados de Rusia y Ucrania en Cataluña

(Colom et al., 2021)

6. Medidas preventivas

Panorama internacional

Modelo canadiense de 4 niveles (Wolfson et al., 2022)

1 — Nivel 1. Prevención universal
- Campañas de sensibilización y promoción de la salud
- Intervenciones escolares y materiales formativos
- Estrategias comunitarias
- Etiquetado de envases
- Avisos en puntos de venta

2 — Nivel 2. Detección precoz e intervención breve
- Programas preconcepcionales (CHOICES)
- Guías clínicas y protocolos sanitarios

3-4 — Niveles 3 y 4. Apoyo integral y tratamiento
- Cribado
- Intervención breve: entrevista motivacional/SBIRT
- Gestión de casos
- Coordinación entre servicios

Formación profesional continuada, coordinación y detección precoz del TEAF

Enfoques adaptados al contexto sociocultural y a las necesidades de las mujeres.

Perspectiva no estigmatizadora

Políticas multicomponente

Nota. CHOICES: *Changing High-Risk Alcohol Use and Improving Contraception Effectiveness;* SBIRT: *Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment.*

Fuentes: Adebiyi et al., 2019; Bruguera et al., 2024; Chang, 2023; De Vries et al., 2016; Fiorentino et al, 2024; Symons et al., 2020; Wolfson et al., 2019, 2022; Wolfson y Poole, 2023

España

Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, 2025):
- Guías para profesionales y población general
- Formación profesional
- Campañas de sensibilización/Infografías

Sociedad científica Socidrogalcohol
Espacio científico y de capacitación profesional

Actuaciones autonómicas
- Guías específicas (Andalucía, Canarias, C. Valenciana)
- Registro en historia clínica (Aragón, Galicia, Navarra, Cantabria)
- Capacitación profesional (Cataluña)

Tejido asociativo de familias (VisualTEAF, AFASAF)
Labor en apoyo, sensibilización escolar y orientación familiar

No existe una estrategia consolidada: iniciativas dispersas y todavía fragmentadas

7. Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Examinar el consumo de alcohol durante el embarazo en relación con el riesgo percibido de daño fetal, el nivel de conocimiento sobre sus posibles efectos en el feto y los factores asociados a esta conducta, con el fin de generar evidencia útil para orientar futuras acciones preventivas en España.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Examinar la asociación entre el consumo de alcohol durante el embarazo y distintos factores de riesgo.
2. Analizar la percepción de riesgo y el conocimiento sobre los efectos fetales del alcohol según el patrón de consumo gestacional.
3. Analizar la estructura interna del cuestionario *ad hoc*.
4. Formular un modelo predictivo del consumo de alcohol gestacional, incorporando los factores de riesgo más relevantes.
5. Describir las fuentes de información sobre el consumo de alcohol gestacional y las preferencias respecto a los profesionales o medios para recibirla.
6. Proponer medidas de actuación orientadas a la planificación de una estrategia preventiva del consumo de alcohol gestacional en España.

MÉTODO

1. Obtención de la muestra

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y PROCEDIMIENTO

Criterios de inclusión

- Mujeres de 18-45 años.
- Embarazadas y/o con descendencia.
- Lengua: española.
- Respuesta ítem clave: consumo de alcohol durante el embarazo.

Cuestionario online, autoadministrado, voluntario y anónimo.

1 Fase 1

Nov. 2020 – Dic. 2021

Reclutamiento directo.
Difusión por email y WhatsApp.
Procedimiento de muestreo en bola de nieve.

2 Fase 2

Feb. 2022 – Nov. 2022

Se mantuvo la misma estrategia de difusión y captación.

3 Fase 3

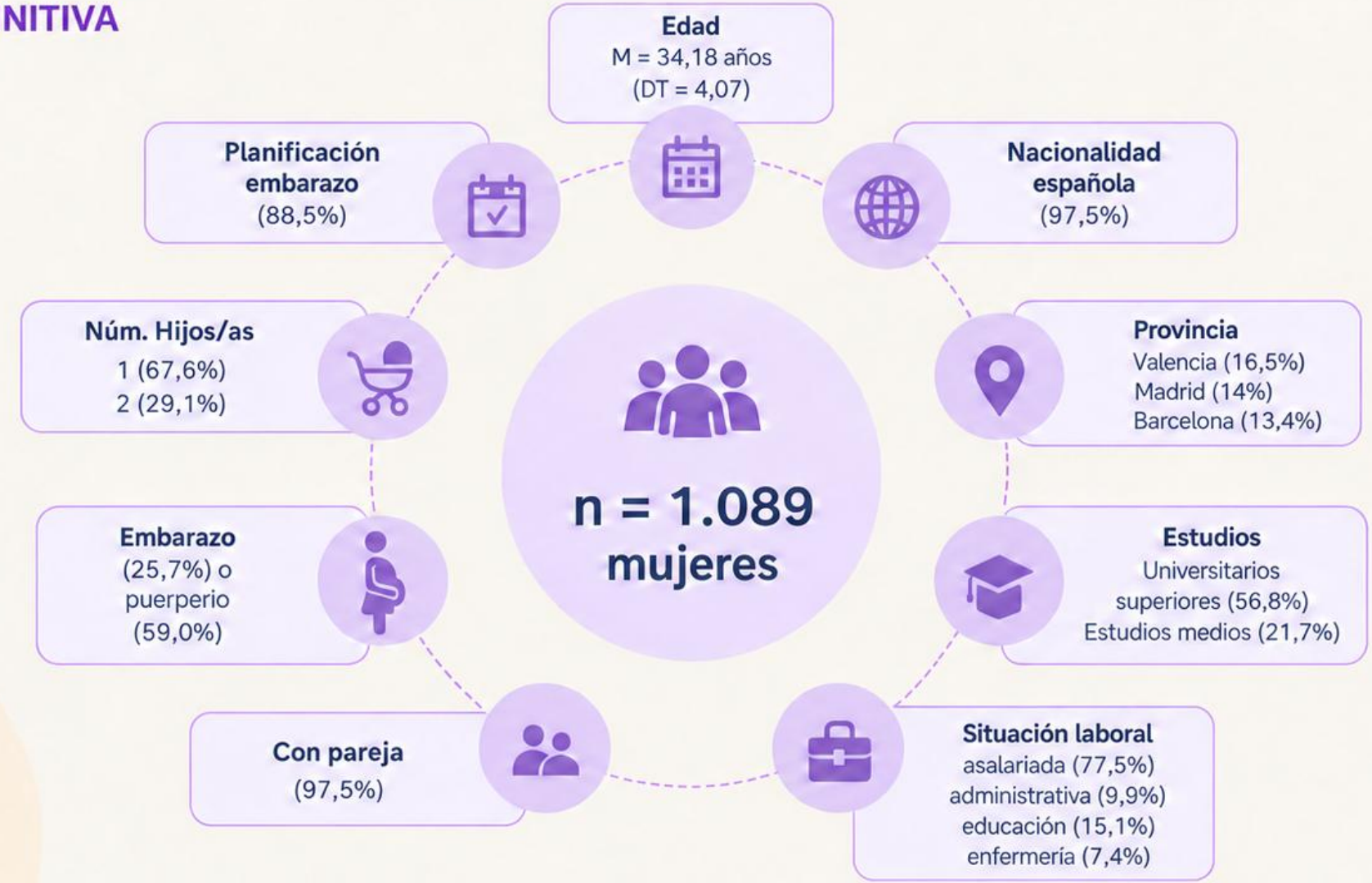
Dic. 2022

Difusión a través de un profesional sanitario con amplia presencia en redes sociales.

Total respuestas alcanzadas: 1.144

2. Descripción de la muestra definitiva

MUESTRA DEFINITIVA



Nota: n = número de participantes; M = Media; DT = Desviación típica; Núm. = Número.

3. Instrumento y variables

CUESTIONARIO *AD HOC* AUTOADMINISTRADO

Basado en 2 estudios (Corrales-Gutiérrez et al., 2019; Environics Research Group, 2000) · Juicio de 3 personas expertas · Pilotaje (n = 5)

1 V. Sociodemográficas, obstétricas y consumo alcohol gestacional

- Edad, nacionalidad, provincia, estudios, ocupación/Sit. Laboral, pareja.
- Sit. Reproductiva, nº hijos/as, planificación.
- Consumo (por T), cantidad (nº copas).

Recodificación variables

- **Edad:** ≤30 / >30 años.
- **Nivel estudios:** <universitarios / ≥universitarios.
- **Ocupación:** alta cualificación, social-educativo, administración/servicios, manual-industrial y sanitario.
- **Nº hijos/as:** < 1 / ≥ 1.
- **Consumo gestacional:** sí / no.
- **Cantidad:** gramos totales.

2 Patrón previo consumo de alcohol

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

(Saunders et al., 1993)

Cálculo nuevas variables

- **AUDIT** Puntuación total · AUDIT-C (ítems 1–3).
- **Consumo:** abstinencia (0) · bajo riesgo (≤5) · riesgo (>5).

3 Consumo otras sustancias

Tabaco, cannabis y otras sustancias antes y durante embarazo.

Recodificación variables

- **Tabaco:** consumo actual (sí / no).
- **Patrón consumo gestacional:** Sin consumo · alcohol · tabaco · alcohol + tabaco · alcohol + cannabis · tabaco + cannabis · alcohol + tabaco + cannabis.

4 Percepción de riesgo y conocimientos

- Percepción y conocimientos: riesgo percibido y efectos del alcohol según bebida/cantidad · Likert 1–4.
- Reversibilidad de consecuencias.
- Presencia de rasgos en hijos/as.

Recodificación variables

- **Riesgo:** correcta (4) / incorrecta (1–3) · índice total de daño fetal.
- **Conocimientos:** correcta / incorrecta según dirección del item · índices totales por dimensión.

5 Fuentes de información

Información recibida y medios/profesionales preferidos · Respuesta múltiple: personal sanitario · familia/amistades · material divulgativo · redes sociales.

Nota: n = número de participantes; Sit. = Situación; nº= número; T = Trimestre

4. Análisis de datos

Descriptivo

Medias, desviaciones típicas, frecuencias y porcentajes.

Estructura interna cuestionario

AFE, KMO, prueba de esfericidad de Bartlett y alfa de Cronbach.

Recodificación de variables

Edad, nivel educativo, número de hijos/as, consumo alcohol gestacional, tabaco e índices de daño fetal y conocimientos, etc.

Modelo predictivo

Cálculo puntuaciones factoriales tipificadas. Regresión logística binaria: bondad de ajuste (Hosmer-Lemeshow); capacidad explicativa (R^2 de Cox y Snell / Nagelkerke), y capacidad discriminativa (ROC y AUC). Multicolinealidad: VIF.

Asociaciones y comparaciones

Chi-cuadrado y OR con IC95%; t de Student y ANOVA; Welch y Brown-Forsythe y tamaño del efecto.

Fuentes informativas

Análisis de respuestas múltiples (frecuencia y porcentajes de casos) y comparaciones mediante chi-cuadrado.

Nota: OR = Odds ratio; IC95% = Intervalo de confianza del 95% ; ANOVA = Análisis de la varianza; AFE = Análisis factorial exploratorio; KMO = índice Kaiser-Meyer- Olkin; R^2 = Coeficiente de determinación; ROC = curva *Receiver Operating Characteristic*; AUC = Área bajo la curva; VIF = Factores de inflación de la varianza.

Software empleado: **IBM SPSS** Statistics 29.0

RESULTADOS

Patrón de consumo previo y consumo gestacional

Patrón de consumo previo de alcohol

AUDIT: M = 3,08 (DT = 2,83)

Abstemias	Consumidoras de bajo riesgo	Consumidoras de riesgo
18,6%	**63,6%**	**17,7%**

AUDIT-C = 2,51 (DT = 1,99)

Patrón de consumo de alcohol gestacional

29,3%

1er trimestre

Gramos
M = 24,8 (DT = 29,8)
Ingestas más frecuentes: 10 (55,7%) y 20 gramos (17,9%).

Otras sustancias: **24,4%**

- Tabaco: 12,3%
- Alcohol y tabaco: 7,6%
- Alcohol, tabaco y cannabis: 1,7%
- Tabaco y cannabis: 1,7%
- Cannabis: 0,6%
- Alcohol y cannabis: 0,5%

Nota: M = Media; DT = Desviación típica.

1. Factores asociados al consumo de alcohol gestacional

Variable	Categoría	*n* No consumidora (%)	*n* Consumidora (%)	Contraste	Magnitud
Edad	≤ 30 años	143 (77,7)	41 (22,3)	$\chi^2(1) = 5,25$, **p = 0,022**	OR = 1,54
	> 30 años	627 (69,3)	278 (30,7)		
Nivel educativo	< Universitario	325 (68,9)	147 (31,1)	$\chi^2(1) = 1,38$, p = 0,240	-
	Universitario	445 (72,1)	172 (27,9)		
Planificación embarazo	No	69 (55,2)	56 (44,8)	$\chi^2(1) = 16,39$, **p < 0,001**	OR = 2,16
	Si	701 (72,7)	263 (27,3)		
Paridad	Primípara	529 (71,9)	207 (28,1)	$\chi^2(1) = 1,495$, p = 0,221	-
	Multípara	241 (68,3)	112 (31,7)		
Consumo tabaco	Nunca	609 (73)	225 (27)	$\chi^2(3) = 10,17$, **p = 0,017**	-
	Algunas veces	48 (67,6)	23 (32,4)		
	Con frecuencia	28 (60,9)	18 (39,1)		
	A diario	85 (61,6)	53 (38,4)		

Variable	Categoría	Puntuación consumidora	Puntuación no consumidora	Contraste	Magnitud
Consumo previo alcohol	AUDIT-C	M = 4,15, DT = 1,74	M = 1,83, DT = 1,66	t(1087) = -20,670, p < **0,001**	d = 1,38

Relación entre consumo previo de alcohol y tabaco.

Las fumadoras ocasionales presentaron mayor AUDIT-C que las no fumadoras (M = 2,99 vs. 2,30; DT = 1,83 vs. 1,90), ***t*(903) = -2,913**; p = **0,004**; **d = 0,36.**

Nota: χ^2 = Estadístico chi cuadrado de Pearson; p = Nivel de significación estadística, OR = Odds ratio; M = Media; DT = Desviación típica; d = tamaño del efecto de Cohen.

2. Conocimientos sobre los posibles efectos en el feto del consumo gestacional

Percepción de daño

Índice daño	No consumidoras M (DT)	Consumidoras M (DT)	F; p	η^2
Daño físico	34,91 (2,46)	24,62 (4,17)	F = 2549,86; p < 0,001	0,701
Deformidad física	10,42 (1,89)	5,65 (1,198)	F = 1748,91; p < 0,001	0,617
Crecimiento fetal	7,98 (2,55)	5,04 (1,44)	F = 372,78; p < 0,001	0,255
Crecimiento cerebral	6,49 (0,95)	4,34 (0,64)	F = 1370,84; p < 0,001	0,558
Alteración cognitiva/conductual	9,00 (1,36)	6,18 (1,16)	F = 1060,56; p < 0,001	0,494

Percepción de reversibilidad

Reversibilidad	No consumidoras M (DT)	Consumidoras M (DT)	F; p	η^2
Crecimiento	2,80 (3,04)	5,96 (2,66)	F = 261,64; p < 0,001	0,194
Crecimiento cerebral	0,79 (1,27)	2,25 (1,89)	F = 219,81; p < 0,001	0,168
Alteraciones cognitivas y conductuales	5,18 (2,26)	6,84 (2,03)	F = 128,98; p < 0,001	0,106
Aborto	0,25 (0,78)	0,85 (1,40)	F = 81,14; p < 0,001	0,069
Prematuridad	0,51 (0,95)	0,65 (1,41)	F = 3,87; p = 0,049	0,004
Síndrome abstinencia	3,39 (3,44)	5,20 (2,81)	F = 69,50; p < 0,001	0,060

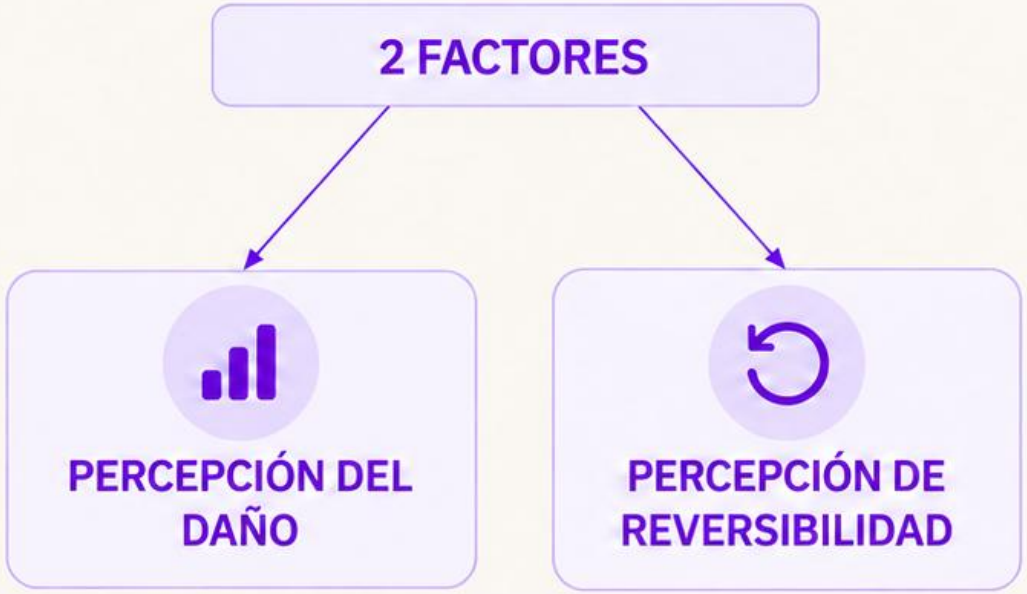
Las mujeres **no consumidoras** perciben un **mayor riesgo asociado** al consumo de alcohol durante el **embarazo**

Las **consumidoras** tienden a percibir como **más reversibles** las consecuencias del consumo gestacional de alcohol

Nota: M = Media; DT = Desviación típica; F = estadístico F de Fisher-Snedecor (ANOVA); p = Nivel de significación estadística; η^2 = eta cuadrado (tamaño del efecto).

3. Estructura interna del cuestionario *ad hoc*

ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO FINAL



Ítem	Factor 1	Factor 2	Comunalidad
Índice daño físico	0,873	-0,201	0,802
Índice deformidad física	0,869	-0,204	0,797
Índice crecimiento cerebral	0,797	-0,022	0,635
Índice alteración cognitiva/conductual	0,789	-0,175	0,653
Reversibilidad prematuridad	0,135	0,774	0,618
Reversibilidad crecimiento cerebral	-0,354	0,712	0,633
Reversibilidad crecimiento	-0,380	0,694	0,626
Consistencia interna (α de Cronbach)	0,767	0,563	-

Varianza total = 68,05%
KMO = 0,828
Esfericidad de Barlett: $\chi^2(21) = 3244,59$; $p < 0,001$

Nota: KMO = índice Kaiser-Meyer-Olkin; χ^2 = Estadístico chi cuadrado de Barlett; p = Nivel de significación estadística; α = Alpha de Cronbach.

4. Predictores del consumo de alcohol gestacional

AJUSTE GLOBAL Y CAPACIDAD PREDICTIVA Y DISCRIMINATIVA

Indicador	Valor
Prueba ómnibus del modelo, χ^2(gl)	1136,566 (5), $p < 0,001$
R^2 de Cox y Snell	0,648
R^2 de Nagelkerke	0,923
Hosmer-Lemeshow, χ^2(gl)	3,900 (8), $p = 0,866$
Clasificación correcta de no consumidoras	97,9%
Clasificación correcta de consumidoras	94,4%
Clasificación global correcta	96,9%
AUC	0,995

Nota: χ^2 = estadístico chi-cuadrado; gl = grados de libertad; p = nivel de significación estadística; R^2 = coeficiente de determinación; AUC = Área bajo la curva.

PREDICTORES INDIVIDUALES DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA

Predictor	B	*p*	OR	IC 95% OR
Edad > 30 años	1,422	0,002	4,146	1,721-9,984
Planificación del embarazo	0,140	0,795	1,150	0,400-3,304
Tabaco actual	-0,323	0,496	0,724	0,286-1,834
Factor 1. Percepción del daño	-5,281	< 0,001	0,005	0,002-0,013
Factor 2. Percepción de la reversibilidad de las consecuencias	1,286	< 0,001	3,619	2,322-5,641

Nota: B = coeficiente de regresión logística; p = nivel de significación estadística; OR = odds ratio; IC95% OR = intervalo de confianza del 95% de la odds ratio.

Modelo sin problemas de multicolinealidad

- VIF (factor de inflación de la varianza): 1,02–1,06
- Tolerancia: 0,95-0,98
- Índice de condición máximo: 5,44

5. Fuentes informativas sobre el consumo de alcohol gestacional

FUENTES DE INFORMACIÓN RECIBIDA

Matrona y/o ginecóloga/o	Internet	Libros o revistas especializados	Redes sociales
64,7%	54%	48,0%	40,5%

FUENTES DE INFORMACIÓN DESEADAS

Matrona y/o ginecóloga/o	Profesional preparación parto	Médico/a de cabecera	Campañas gubernamentales
93,8%	59,6%	54,5%	39,0%

Fuentes de información según consumo gestacional

- Distribución similar entre consumidoras y no consumidoras.
- La única diferencia significativa fue en **"nadie informó"**, más frecuente entre las consumidoras, $\chi^2(1) = 4,48$; $p = 0,034$.

Fuentes de información según consumo gestacional

- Distribución similar entre consumidoras y no consumidoras.
- No se observaron diferencias significativas. Las **campañas gubernamentales** mostraron una tendencia, siendo más frecuentes entre las no consumidoras, $\chi^2(1) = 3,76$; $p = 0,052$.

Nota: χ^2 = Estadístico chi cuadrado de Pearson; p = Nivel de significación estadística.

DISCUSIÓN

Consumo de alcohol gestacional

1 de cada 3 mujeres

Periodo vulnerable

Aceptación social

Prevalencia

- Superior a las estimaciones generales para España y Europa
- Coherente con estudios nacionales basados en autoinforme

Fuentes: Blasco-Alonso et al., 2015; Corrales-Gutiérrez et al., 2019; Popova et al., 2017.

Posible infraestimación

- Autoinforme vs. biomarcadores
- Estigma asociado
- Conciencia insuficiente del problema → percepción atenuada del riesgo

Fuentes: Chiandeetti et al., 2017; Erng et al., 2023; García-Algar et al., 2008; Gómez-Roig et al., 2018; Keating et al., 2024; Lange et al., 2014; Lyall et al., 2021; Oni et al., 2019, 2022; Weber et al., 2021.

Concordancia con la literatura

- **Mayor vulnerabilidad en las primeras semanas**, cuando el embarazo puede no haberse reconocido aún
- **Continuidad de patrones previos de consumo** y dificultad para modificar hábitos establecidos.

Fuentes: Lenie et al., 2025; McCormack et al., 2017; Muggli et al., 2016; Skagerström et al., 2011.

Percepción de algunas cantidades como aceptables o de bajo riesgo

Implicaciones clínicas:

- ✓ Cribado (Dozet et al., 2023)
- ✓ Optimización entrevista clínica
- ✓ Contexto asistencial no culpabilizante

Factores asociados al consumo de alcohol gestacional

SOCIODEMOGRÁFICOS

Edad > 30 años

- ✓ Coincide con Lanting et al., 2015; McCormack et al., 2017; O'Keeffe et al., 2015; Saxov et al., 2023; Skagerström et al., 2013; Tan et al., 2015; Tsang et al., 2022.
- ✓ **Mayor consolidación de hábitos previos** y posible resistencia al cambio.
- ✓ **Contextos socioeconómicos más estables** → mayor normalización del consumo (Mendoza et al., 2021).
- ✓ **Edad** como **marcador holístico** de estilos de vida, trayectorias de consumo y contexto sociocultural.

Nivel educativo

- ✓ Evidencia previa heterogénea: asociaciones en ambas direcciones (Aryal et al., 2016; Blasco-Alonso et al., 2015; Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Dumas et al., 2017; Lanting et al., 2015; Márdby et al., 2017; McCormack et al., 2017; O'Keeffe et al., 2017; Onwuka et al., 2016; Tan et al., 2015). No asociación en esta muestra.
- ✓ Escasa variabilidad educativa: predominio de mujeres universitarias.
- ✓ Conductas de riesgo también presentes en población altamente cualificada.

OBSTÉTRICOS

No planificación

- ✓ Coherente con McCormack et al., 2017; Petersen-Williams et al., 2018; Yu et al., 2022.
- ✓ Continuidad del patrón previo en las primeras semanas, antes de confirmar el embarazo → ausencia de anticipación conductual y menor oportunidad de cambio precoz.
- ✓ **Implicación preventiva**: reforzar **estrategias preconcepcionales** → cribado en atención primaria y salud sexual/reproductiva + promoción de anticoncepción eficaz (Reid et al., 2021).

Paridad

- ✓ Literatura dividida: mayor consumo descrito tanto en primíparas como en multíparas (Corrales-Gutiérrez et al., 2020; McCormack et al., 2017; O'Keeffe et al., 2015; Onwuka et al., 2015; Saxov et al., 2023; Senecky et al., 2025).
- ✓ Podría no actuar de forma aislada, sino depender del contexto sociocultural, la trayectoria reproductiva y otros factores más próximos al consumo.

CONDUCTUALES

Consumo tabaco

- ✓ **Coexistencia de conductas de riesgo**: asociación entre consumo de alcohol y tabaco (Dumas et al., 2017; Lanting et al., 2015; Márdby et al., 2017; McCormack et al., 2017; O'Keeffe et al., 2015; Saxov et al., 2023; Senecky et al., 2025; Skagerström et al., 2013).
- ✓ Incluso el **tabaquismo ocasional** se asocia con un **mayor consumo previo** de alcohol.
- ✓ **Posibles determinantes compartidos**: persistencia de hábitos previos y contextos de elevada normalización social.

Consumo previo alcohol

- ✓ **Variable clave del consumo gestacional**, en línea con la literatura previa(Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Onwuka et al., 2016; Senecky et al., 2025; Skagerström et al., 2011, 2013; Tsang et al., 2022).
- ✓ **Persistencia de hábitos previos** y dificultad para modificar **conductas normalizadas**.
- ✓ **Implicación preventiva**: actuar desde la **etapa preconcepcional** (Reid et al., 2021).

Conocimientos sobre los posibles efectos en el feto del consumo gestacional

Las mujeres consumidoras muestran una menor percepción del daño asociado al consumo de alcohol gestacional y una mayor percepción de reversibilidad de las posibles consecuencias fetales.

Coherente con estudios previos en los que se vincula el consumo de alcohol gestacional con una baja percepción del riesgo (Corrales-Gutiérrez, 2020; Tsang et al., 2022) y con creencias erróneas sobre la inocuidad de dosis moderadas o bebidas específicas (Botella-López y Cortés-Tomás, 2025).

Procesos psicológicos de minimización del daño

- **Más allá de la información objetiva:** el consumo no depende solo del acceso a la información, sino también de procesos cognitivos de relativización y atenuación del riesgo.
- **Percepción de bajo riesgo:** determinadas situaciones o consumos esporádicos/leves pueden interpretarse como poco relevantes o insuficientemente peligrosos.

Complejidad en la toma de decisiones

La decisión de consumir no depende de un único factor: integra normas sociales, creencias sobre la gravedad y duración del daño y percepciones subjetivas de seguridad (Erng et al., 2023).

Estructura interna del cuestionario *ad hoc*

PERCEPCIÓN DEL RIESGO: UN CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL

(Brewer et al., 2007; Erng et al., 2023; Slovic, 1987, 2000; Weinstein, 1989)

PERCEPCIÓN DEL DAÑO FETAL

- **Elemento central en la construcción del riesgo percibido** y en la modulación de conductas relacionadas con la salud (Brewer et al., 2007; Rosenstock, 1974).
- **Cargas elevadas y alta consistencia interna:** el daño físico, cerebral y cognitivo/conductual se integra en una **representación unificada del impacto negativo del alcohol sobre el feto.**

PERCEPCIÓN DE LA REVERSIBILIDAD DE CONSECUENCIAS

- **Diferenciar daño y permanencia:** reconocer que existe un daño no implica percibirlo como duradero o irreversible.
- **Posible atenuación cognitiva del riesgo:** una menor percepción de permanencia puede favorecer valoraciones menos alarmantes y actitudes más permisivas hacia el consumo gestacional.
- **Mayor heterogeneidad del factor:** podría reflejar diferencias en la valoración de secuelas menos visibles o abstractas, como las alteraciones cognitivo-conductuales, frente a consecuencias físicas más evidentes.

IMPLICACIONES PREVENTIVAS

- ✓ Intervenir no solo sobre el **contenido del mensaje**, sino también sobre la **percepción de la gravedad y permanencia del daño** (Gerrard et al., 2008; Rosenstock, 1974).
- ✓ Utilizar **materiales psicoeducativos y mensajes clínicos claros**, con ejemplos concretos de las consecuencias físicas, cognitivas y conductuales asociadas a la exposición prenatal al alcohol.
- ✓ Reforzar especialmente la **persistencia de las secuelas** y su **impacto funcional en la vida cotidiana**.

Predictores del consumo de alcohol gestacional

El modelo multivariable sitúa las **variables cognitivas** como elementos centrales en la explicación del **consumo de alcohol gestacional**

MARCADORES DE VULNERABILIDAD

Tabaco y no planificación

Asociaciones atenuadas tras incorporar las variables cognitivas

Edad >30 años

Mantiene capacidad explicativa independiente → **marcador consolidado**

MECANISMOS INMEDIATOS

Percepción de daño y reversibilidad

Variables cognitivas próximas a los mecanismos inmediatos de la conducta.

Coherente con modelos generales de conducta preventiva y estudios específicos sobre alcohol gestacional.

(Brewer et al., 2007; Corrales-Gutiérrez et al., 2020; Erng et al., 2023; Tsang et al., 2022).

CAPACIDAD DISCRIMINATIVA

Las dimensiones **cognitivas** muestran un posible **valor discriminativo** entre **consumidoras y no consumidoras** gestacionales

Confirmar su estabilidad en estudios futuros

IMPLICACIÓN PREVENTIVA

Perfiles de riesgo multidimensionales

Integrar factores sociodemográficos, obstétricos, conductuales y **cognitivos.**

Implicación: incorporar la evaluación y el abordaje de las creencias sobre el daño fetal y la reversibilidad de sus consecuencias.

Fuentes informativas sobre el consumo de alcohol gestacional

Legitimidad de la persona emisora

- Canales informales vs **profesionales**.
- **Credibilidad del mensaje**: fuentes reputadas, claras y no contradictorias.

(Anderson et al., 2014; Hocking et al., 2020; Lyall et al., 2021)

Oportunidad digital

Uso de internet y redes sociales → contenidos rigurosos, comprensibles y avalados profesionalmente

(Oh et al., 2022; Wolfson et al., 2022)

Vulnerabilidad asociada a la ausencia de información

La mayor frecuencia de ausencia de información entre las **consumidoras** podría reflejar una **menor percepción del riesgo** y de sus posibles **consecuencias**.

Campañas gubernamentales

Acciones institucionales sostenidas → Desnormalización social del consumo

(Jacobsen, 2022)

Figuras sanitarias

- **Matrona** en el centro de la prevención: relación de confianza y cercanía → cribado, consejo breve e intervención motivacional (Payne et al., 2014; Smith et al., 2021).
- Necesidad de incorporar otros perfiles sanitarios y en diferentes contextos asistenciales.

Formación y capacitación continua del personal sanitario

Superar barreras formativas y organizativas

(Dyson et al., 2023; Howlett et al., 2019; McCormack et al., 2022)

Prevención en España: implicaciones prácticas

Estrategia multinivel y multicomponente

(Adebiyi et al., 2019; Bruguera et al., 2024; Ministerio de Sanidad, 2025; Wolfson y Poole, 2023; Wolfson et al., 2022)

1 Universal

Actuar sobre el **ideario social** del consumo de alcohol

- ✓ Campañas públicas sostenidas
- ✓ Etiquetado de bebidas
- ✓ Sensibilización en espacios de consumo
- ✓ Contenido específico en programas escolares

Población general y mujeres en edad fértil

2 Selectiva

Ventana estratégica: **periodo pre y periconcepcional**

- ✓ Cribado sistemático en atención primaria, y salud sexual y reproductiva
- ✓ Intervención breve estructurada
- ✓ Reducción consumo + anticoncepción (CHOICES)
- ✓ Herramientas digitales: cribado, autoevaluación, seguimiento y educación

Mayor vulnerabilidad: patrón previo, tabaquismo y embarazo no planificado

3 Indicada

Detección precoz, reducción del riesgo y acompañamiento

- ✓ Detección: reducir la culpa y aumentar percepción riesgo
- ✓ Intervención breve motivacional
- ✓ Coordinación y derivación a servicios especializados

Mujeres en consumo, probabilidad de mantenerlo o perfil de riesgo elevado

4 Formación, detección precoz y coordinación

Formación continuada del personal sanitario

- Cribado, entrevista motivacional, cuantificación del consumo, comunicación y detección precoz.
- Desnormalización del consumo dentro del sistema sanitario.

Implicación diagnóstica: detección precoz del TEAF y apoyo coordinado

Materiales con ejemplos funcionales y signos de alarma, circuitos de derivación y espacios conjuntos de formación

Enfoque no estigmatizante

Fuentes: Adebiyi et al., 2019; Burns et al., 2010; Dozet et al., 2023; Fernandes-Magalhaes et al., 2025; Fiorentino et al., 2024; Floyd et al., 2007; Jacobsen et al., 2022; Khoury y Miligan, 2019; Ministerio de Sanidad, 2025; Popova et al., 2023; Thomas et al., 2014; Yu et al., 2022.

Fortalezas, limitaciones y líneas futuras

FORTALEZAS

- ✓ Tamaño muestral amplio.
- ✓ Enfoque integral: consumo, percepción de riesgo, conocimientos y fuentes informativas.
- ✓ Análisis factorial exploratorio: precisar mecanismos cognitivos asociados.
- ✓ Orientación aplicada: evidencia empírica para estrategias preventivas.

LIMITACIONES

- Autoinforme y posible infradeclaración del consumo.
- Muestra con alto nivel educativo y ocupaciones cualificadas.
- Ausencia de variables del entorno social.
- Diseño transversal: asociación, no causalidad.
- Consistencia interna del factor de reversibilidad: seguir refinando este constructo.

LÍNEAS FUTURAS

- ➢ Muestras más heterogéneas.
- ➢ Estudios longitudinales.
- ➢ Validación confirmatoria del cuestionario.
- ➢ Contrastar la capacidad predictiva del modelo en otras muestras y contextos.
- ➢ Inclusión de variables sociales e interpersonales.
- ➢ Evaluación de intervenciones preventivas concretas.



Gracias por escuchar, cuestionar y contribuir



- *Mama vine, que estic fent una cosa molt important pa' mi*
- *I què és?*
- *La tesi*

Andreu, setembre 2026

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA